R. H. Campos, V. de Oliveira, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Suicídio com disparo único de arma de fogo e curta sobrevida: relato de caso

R. H. Campos[a,*], V. de Oliveira[a]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Francisco Beltrão (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: rafael.campos@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-41-99924-6238.*

Palavras-chave: suicídio; arma de fogo; local de morte; medicina legal; relato de caso

1. INTRODUÇÃO

No estado do Paraná, o disparo de arma de fogo figura como o segundo método de autocídio mais comum[1,2], ocorrendo majoritariamente com disparo único contra a cabeça e óbito imediato. O presente trabalho descreve uma variação pouco corriqueira desta modalidade, onde o autor realizou disparo singular contra a cabeça e permaneceu consciente e ativo por alguns minutos após o ato, a despeito da intensidade da lesão sofrida.

Estão expostos os elementos essenciais da diagnose diferencial deste caso, de maneira descritiva e formando uma cadeia de raciocínio completa e fundamentada.

2. OBJETIVOS

Relatar um caso atípico de suicídio com arma de fogo e demonstrar a importância do trabalho conjunto entre a equipe de perícia de local de crime e a equipe de necropsia para a correta interpretação dos vestígios encontrados.

3. RELATO DO CASO

3.1. O local

Por volta das 16 h, a equipe de exame de local de morte foi acionada para perícia em um caso de suposto suicídio com arma de fogo, ocorrido em uma residência. Chegando lá, foi encontrada cena com multiplicidade de manchas hematoides, dispostas em três cômodos distintos e ligadas em continuidade.

Além das forças de segurança, encontrava-se no local o noticiante, que confirmou ter circulado no interior da residência e tocado na vítima antes do acionamento da polícia.

Os cômodos de interesse principal correspondiam à sala (com um sofá), banheiro e cozinha, com estes últimos conectados entre si a partir da sala. A Figura 1 exibe as manchas hematoides dispostas na junção destes três ambientes. O cadáver se encontrava em decúbito dorsal no piso da cozinha, também envolto em uma multiplicidade de profusas manchas hematoides.

Esta disposição é atípica para um local de suicídio e, neste contexto, a primeira linha de análise forense foi avaliar a possibilidade de um segundo envolvido.



Figura 1. Diversidade de manchas hematoides, dispostas entre o local de disparo e o local de óbito.

3.2. A arma e o disparo

A arma utilizada foi um revólver Taurus.38 Special de propriedade da vítima, que se encontrava caído no piso adjacente ao provável local de disparo. O tambor continha cinco cartuchos intactos e um

estojo deflagrado, alinhado com a câmara. O local provável onde o disparo ocorreu consistia em um sofá, e nele foi observada sombra nas manchas hematoides[3], com silhueta compatível com um indivíduo adulto sentado.

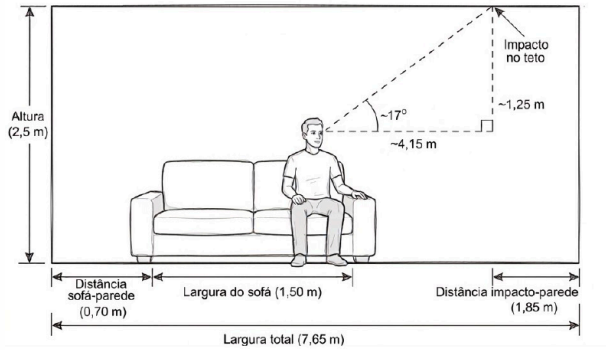


Figura 3. Diagrama ilustrativo das medições utilizadas para calcular o ângulo da trajetória do projétil.

Tendo encontrado também a marca de impacto do projétil no forro do ambiente, e realizadas as medições apropriadas (altura da vítima fatal, dimensões do cômodo, posição de impacto do projétil no teto, posição do sofá e estimativa da posição de um adulto sentado ali), inferiu-se que após sair da cabeça da vítima o projétil seguiu em trajetória[4] ascendente de 17±3°.

3.3. Das manchas hematoides

No levantamento de local, entre outras, foram observadas manchas hematoides, aqui descritas e interpretadas, identificando-se os seguintes mecanismos de produção[3]:

- gotejamento isolado estático e gotejamento sucessivo estático, no caminho entre o banheiro e a cozinha, associadas a escorrimento e desprendimento a partir da vítima enquanto caminhando em marcha lenta e com pouca agitação dos membros;
- empoçamento, à frente do sofá, no banheiro e na cozinha, derivada de profuso sangramento da vítima, ao permanecer nestes locais por tempo moderado em posição estática ou quase-estática, as do banheiro eram acompanhadas de grande quantidade de gotículas satélite;



Figura 2. Revólver .38 SPL encontrado, onde é visível o espargimento hematoide de retorno.



Figura 4. Manchas hematoides no sofá e adjacências, onde é visível a área de sombra com a silhueta de pernas.

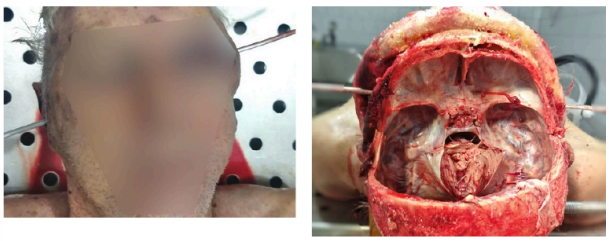
- ausência de manchas, na forma de área de sombra, no assento esquerdo do sofá, associáveis a um indivíduo adulto sentado;
- espargimento de saída e espargimento de retorno, presentes no tecido do sofá, no piso a frente do sofá e na armação do revólver, as do sofá em posição compatível com indivíduo adulto sentado;
- transferência por contato, com impressão do solado da vítima ligando todos os três cômodos, no trecho salabanheiro as impressões são em trajetória retilínea e com espaçamento aproximadamente regular, no trecho banheiro-cozinha são com orientação e espaçamento significativamente mais erráticos do que no primeiro;
- transferência por contato, com impressão do solado do noticiante indicando caminho da cozinha até o banheiro, e após, até a porta, não há presença de impressões destes solados nas adjacências do sofá e as do banheiro são em pequena quantidade;
- transferência por contato e arrastamento, com esfregaços nas paredes entre o banheiro e a cozinha, sugerindo tentativa da vítima de se apoiar nestes locais, a da cozinha, próxima ao cadáver, é mais comprida e vai mais baixo na parede, associada com tentativa de apoio seguida de queda;
- escorrimento, das manchas dispostas nas paredes, tanto as espargidas quanto as depositadas.



Figuras 5 a 8. *(esquerda para a direita, cima para baixo)* Exemplo das manchas hematoides encontradas: gotejamento sucessivo no caminho entre o banheiro e a cozinha; esfregaço nos azulejos da cozinha, entre o cadáver e a porta a partir da sala; impressão do calçado da vítima; impressão do calçado do noticiante.

3.4. O cadáver

Ao exame do cadáver, no local, foi observada uma lesão perfurocontusa na hemiface direita, compatível com a entrada de projétil de arma de fogo em disparo encostado[5], e também uma lesão perfurocontusa na hemiface esquerda, compatível com a saída do mesmo. Também foi notado amplo espargimento de sangue na face, nos membros superiores e nas vestes, incompatíveis com escorrimento unicamente sob a ação da gravidade e sugestivos de dispersão por movimento voluntário dos membros. A temperatura abdominal foi medida em 33,6±0,5 °C. O cadáver então foi removido ao Serviço Médico-Legal, onde a equipe responsável pela perícia de local acompanhou os trabalhos, expondo os achados à equipe de necropsia, que muito cuidadosamente procedeu com a abertura do crânio, evitando lesões no encéfalo. Seccionado o crânio e removido o encéfalo, notou-se a preservação do tecido ósseo da face interna do crânio (visível na figura 10). Com o auxílio de uma haste metálica, foi possível confirmar o trajeto[4] do projétil, ocorrido à frente da caixa encefálica, sem penetrar nela, e inclinado em ângulo ascendente de 16±2 ° (medido através das fotografias do rosto, relativas às linhas glabela-mento e bipupilares).



Figuras 9 e 10. Cabeça do cadáver durante a necropsia, com haste metálica evidenciando o trajeto do projétil e com a visível preservação da parede óssea interna do crânio.

O exame médico-legal apontou hemorragia aguda com fratura de ossos do crânio e da face como causa da morte.

3.5. Da hipótese conclusiva

Somando-se ao já descrito, não foram encontrados vestígios sugestivos de arrombamento, de furto/roubo ou de luta corporal em todo o interior da residência. Também não foram observadas manchas alteradas por limpeza ou esfregaços interpretáveis como intencionalmente produzidos.

A partir da interpretação dos vestígios observados, a dinâmica mais compatível com os achados é a de que o autor (e vítima) sentou-se sobre o sofá da sala da residência e, em posse do revólver, com a mão direita, realizou disparo encostado na hemiface direita da cabeça. O projétil transfixou o crânio à frente da caixa encefálica, no terço lateral entre o tragus e o epicanto do olho direito, saindo pela hemiface esquerda, também em terço lateral, entre o tragus e epicanto do olho esquerdo, iniciando um profuso sangramento a partir desta lesão. O autor teria então caminhado em linha quase reta, com passos curtos, até o banheiro, onde se movimentou amplamente à frente da pia existente, realizando então nova caminhada até a cozinha, com passos mais erráticos, onde, após infrutífera tentativa de se manter erguido, tombou sobre o piso, movimentando-se ali até perder os sentidos, com óbito subsequente.

Diversos outros trabalhos forenses abordam casos análogos (exemplificado pela ref. [6], que também explicita que disparos que não atinjam diretamente o sistema nervoso central resultam ocasionalmente em eventos de natureza similar, e pela ref. [7]).

Por fim, tão importante quanto apontar a dinâmica desta ocorrência foi apontar a improbabilidade de segundo envolvido com o fato, com a multiplicidade dos elementos elencados subsidiando as conclusões apontadas.

4. CONCLUSÕES

O exame descrito permitiu, além da elucidação do caso, uma análise rica e conjunta da grande quantidade de manchas hematoides encontradas, tanto em termos de forma quanto de disposição. Além disso, é notável a qualidade da informação que se pode obter dos vestígios quando há diálogo e trabalho conjunto entre os diferentes profissionais envolvidos, fomentando este método de trabalho como essencial para resultados periciais robustos.

AGRADECIMENTOS

Ao técnico de perícia Geovane das Neves pelo incrível trabalho durante a necropsia, que permitiu a análise detalhada das lesões do cadáver, à médica Jaqueline Feltz pelas explicações e revisão, e aos servidores da Unidade de Execução Técnico-Científica de Francisco Beltrão envolvidos nas perícias relacionadas, pelo profissionalismo desenvolvido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Rosa, N. M. da., Oliveira, R. R. de., Arruda, G. O. de., & Mathias, T. A. de F.. (2017). Mortalidade por suicídio no Estado do Paraná segundo meios utilizados: uma análise epidemiológica. *Jornal Brasileiro De Psiquiatria*, *66* (2), 73–82. https://doi.org/10.1590/0047-2085000000153

[2] CASSIS, Vinicius Cortez. Mortalidade por suicídio no estado do Paraná: uma análise descritiva do período entre 2008 e 2018. 2021. Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral, Curso de Graduação em Administração Pública. Disponível em: http://hdl.handle.net/1884/99090. Acesso em: 28 mai. 2026.

[3] DIAS FILHO, Claudemir Rodrigues; D'ÁVILA, André Vieira Peixoto; URSINI, Alex Gehringer *et al.* Hematologia Forense: da identificação à análise de manchas de sangue. Campinas: Millennium Editora, 2022. ISBN 978-85-7625-378-5.

[4] TOCHETTO, Domingos. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos. Campinas: Millennium Editora, 2021. ISBN 978-65-990377-4-0.

[5] CUNICO, Edimar. Perícias em locais de morte violenta: criminalística e medicina legal. Curitiba: Ed. do Autor, 2010. ISBN 978-85-9105-540-1.

[6] HEJNA, Petr; ŠAFR, Miroslav; ZÁTOPKOVÁ, Lenka. The ability to act – Multiple suicidal gunshot wounds. Journal of Forensic and Legal Medicine, v. 19, n. 1, p. 1-6, jan. 2012.

[7] WASICEK, Philip J.; KANTAR, Rami S.; YOON, Joshua; ELEGBEDE, Adekunle; NAM, Arthur J. Survival following self-inflicted gunshot injuries to the face using the National Trauma Data Bank. The Journal of Craniofacial Surgery, v. 31, n. 2, p. 411-415, mar./abr. 2020.